Décision n° 2025.0297/DC/SEM du 11 décembre 2025 du collège de la Haute Autorité de santé portant modification de l'autorisation d'accès précoce de la spécialité KEYTRUDA (pembrolizumab)

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 11 décembre 2025.

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu la décision d'autorisation d'accès précoce n°2024.0238 délivrée le 12 septembre 2024 pour la spécialité KEYTRUDA (pembrolizumab) ;
Vu l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité KEYTRUDA (pembrolizumab) modifiée en date du 31 janvier 2025 ;
Vu la demande de modification d'autorisation d'accès précoce présentée par le laboratoire MSD FRANCE reçue le 29 août 2025 ;
Vu l'accusé d'enregistrement de demande complète notifié le 7 octobre 2025 au titulaire ;
Vu la notification de la HAS indiquant la prorogation du délai d'instruction de la demande d'autorisation d'accès précoce, adressée le 7 octobre 2025 au demandeur ;
Vu l'avis de la commission de la transparence en date du 19 novembre 2025 ;

DÉCIDE :

Article 1er

Le médicament **KEYTRUDA (pembrolizumab)** a fait l'objet d'une autorisation d'accès précoce dans l'indication « en association à l'enfortumab vedotin, dans le traitement de première ligne des patients adultes atteints d'un carcinome urothélial non résécable ou métastatique » le 12 septembre 2024 pour la forme :

KEYTRUDA (pembrolizumab) 25 mg/mL, solution à diluer pour perfusion
1 flacon en verre de 4 mL (CIP : 34009 550 243 1 6)

Le laboratoire MSD FRANCE sollicite une modification de l'autorisation d'accès précoce afin d'y intégrer un complément de gamme :

KEYTRUDA (pembrolizumab) 25 mg/mL, solution à diluer pour perfusion
2 flacons en verre de 4 mL (CIP : 34009 551 048 6 5)

Considérant que l'ensemble des critères prévus à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique demeurent remplis, la commission de la transparence (CT) a émis un avis favorable à l'intégration de cette nouvelle présentation à l'accès précoce en cours.

S'appropriant les motifs de la CT, le collège considère donc qu'il y a lieu de modifier la décision n°2024.0238 susvisée comme suit :

A l'article 1er, les mots *:*

« KEYTRUDA (pembrolizumab) 25 mg/ml, solution à diluer pour perfusion
1 flacon en verre de 4 mL (CIP : 34009 550 243 1 6) »

sont remplacés par les mots :

« KEYTRUDA (pembrolizumab) 25 mg/ml, solution à diluer pour perfusion
1 flacon en verre de 4 mL (CIP : 34009 550 243 1 6)
2 flacons en verre de 4 mL (CIP : 34009 551 048 6 5) »

Article 2

Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.

Fait le 11 décembre 2025.

Pour le collège :
Le président de la Haute Autorité de santé,
Pr Lionel COLLET
Signé

AVIS SUR LES MÉDICAMENTS

pembrolizumab

KEYTRUDA 25 mg/ml,

solution à diluer pour perfusion

Modification de l'autorisation d'accès précoce

Adopté par la Commission de la transparence le 19 novembre 2025

- **Carcinome urothélial**
- **Adulte**

Synthèse

La Commission donne un avis favorable à la modification de l'autorisation d'accès précoce de KEYTRUDA (pembrolizumab) dans l'indication « KEYTRUDA, en association à l'enfortumab vedotin, est indiqué dans le traitement de première ligne des patients adultes atteints d'un carcinome urothélial non résécable ou métastatique et éligibles à une chimiothérapie à base de sels de platine » pour y inclure les présentations :

KEYTRUDA 25 mg/ml, solution à diluer pour perfusion

– ***2 flacons en verre de 4 ml (CIP : 34009 551 048 6 5) (UCD : 34008 9419723 2)***

Critères d'éligibilité prévus à l'article L.5121-12 du code de la sante publique	**KEYTRUDA (pembrolizumab) en association au enfortumab vedotin est destinée à traiter une maladie grave et invalidante** dès lors que le cancer urothélial est une maladie grave, engageant le pronostic vital, et invalidante dont les complications détériorent de manière importante la qualité de vie des patients. Ce retentissement sur la qualité de vie est corroboré par les associations de patients. **La combinaison est destinée à traiter une maladie rare** car le nombre de patients en première ligne du carcinome urothélial au stade localement avancé ou métastatique est estimé à environ 6 221 patients par an au maximum.
	Dans l'indication retenue par la CT pour l'accès précoce, à savoir en association à l'enfortumab vedotin, dans le traitement de première ligne des patients adultes atteints d'un carcinome urothélial non résécable ou métastatique et éligibles à une chimiothérapie à base de sels de platine, il n'existe pas de traitement approprié, malgré l'existence de protocoles de chimiothérapie à base de sels de platine, actuellement recommandés au même niveau de la stratégie thérapeutique. **En effet, les protocoles de chimiothérapies à base de sels de platine ne sont pas considérés comme un traitement approprié dans la mesure où :** – La prise en charge repose sur la combinaison gemcitabine – cisplatine suivi par un traitement d'entretien par BAVENCIO (avelumab) chez les patients dont la maladie n'a pas progressé après la chimiothérapie à base de platine. Ces traitements sont accessibles et pris en charge par la solidarité nationale ;

– Les protocoles de chimiothérapies incluant le protocole gemcitabinecarboplatine en cas de contre-indication au cisplatine et MVACdd (méthotrexate + vinblastine + doxorubicine + cisplatine dose dense) sont utilisées hors AMM dans l'indication ;
– L'absence de perte de chance pour les patients qui recevraient ces protocoles de chimiothérapies ne peut être garantie du fait que ces spécialités ne disposent pas de données d'efficacité et de tolérance satisfaisantes au regard de l'apport prévisible de KEYTRUDA (pembrolizumab) en association au enfortumab vedotin.

Par ailleurs, deux spécialités disposent d'une AMM dans un périmètre restreint mais ne sont pas considérées comme des traitements appropriés car elles ne sont pas prises en charge par la solidarité nationale :

– OPDIVO (nivolumab) en monothérapie ;
– KEYTRUDA (pembrolizumab) en monothérapie.

La mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée puisqu'il s'agit d'une maladie grave, rare et invalidante pour laquelle il n'existe pas de traitement approprié.

KEYTRUDA 25 mg/ml (pembrolizumab), solution à diluer pour perfusion, dans l'indication considérée, est présumé innovant dans l'indication considérée, car :

– il s'agit d'une nouvelle modalité de prise en charge susceptible d'apporter un changement substantiel aux patients dans la prise en charge du fait du bénéfice apporté en matière d'efficacité avec des différences estimées sur les médianes de 6,2 mois sur le critère de la survie sans progression et de 15,4 mois sur la survie globale ;
– on ne dispose pas de donnée sur l'apport de cette association chez les patients non éligibles aux sels de platine ;
– le médicament dispose d'un plan de développement adapté et présente des résultats cliniques, pour les patients atteints de cancer urothélial localement avancé ou métastatique naïfs de traitement étayant la présomption d'un bénéfice pour le patient dans le contexte de la stratégie thérapeutique existante ;
– il participe à couvrir davantage un besoin médical partiellement couvert.

Sommaire

1. Contexte **4**

2. Environnement médical **5**

3. Synthèse des données **5**

4. Conclusions de la Commission de la Transparence **6**

4.1 Maladie grave, rare ou invalidante 6

4.2 Absence de traitement approprié 6

4.3 Impossibilité de différer la mise en œuvre du traitement 6

4.4 Caractère présumé innovant notamment au regard d'un éventuel comparateur cliniquement pertinent 7

4.5 Recommandations 7

Ce document ainsi que sa référence bibliographique sont téléchargeables sur www.has-sante.fr

Le présent avis est publié sous réserve des droits de propriété intellectuelle

Haute Autorité de santé – Service communication et information

5 avenue du Stade de France – 93218 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX. Tél. : +33 (0)1 55 93 70 00

© Haute Autorité de santé – Novembre 2025

1. Contexte

Résumé du motif d'évaluation	Accès- précoce - dépôt de nouvelles données
Précisions	Il s'agit d'une demande de modification d'accès précoce de KEYTRUDA (pembrolizumab) 25 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, pour ajouter un nouveau conditionnement de 2 flacons en verre de 4 ml.
Indication concernée par l'évaluation	**Périmètre de l'indication d'AP concerné par la demande** : « KEYTRUDA, en association à l'enfortumab vedotin, est indiqué dans le traitement de première ligne des patients adultes atteints d'un carcinome urothélial non résécable ou métastatique et éligibles à une chimiothérapie à base de sels de platine ».
DCI (code ATC) **Présentation concernée**	pembrolizumab (L01FF02) **KEYTRUDA 25 mg/ml, solution à diluer pour perfusion** – 1 flacon en verre de 4 ml (CIP : 34009 550 243 1 6) (UCD : 34008 9419723 2) – *2 flacons en verre de 4 ml (CIP : 34009 551 048 6 5) (UCD : 34008 9419723 2)* Le conditionnement complémentaire par rapport à la demande d'accès précoce initiale figure en italique ci-dessus.
Laboratoire	MSD FRANCE
AMM (Autorisation de mise sur le marché)	Date initiale (procédure centralisée) : 17/07/2015 Date des rectificatifs et teneur : – 29/08/2024 : extension d'indication en association à l'enfortumab vedotin, dans le traitement de première ligne des patients adultes atteints d'un carcinome urothélial non résécable ou métastatique, – 31/01/2025 : Rectificatif d'AMM pour inclure la nouvelle présentation de KEYTRUDA 25 mg/mL, solution à diluer pour perfusion, afin d'accueillir 2 flacons au lieu de 1. Plan de Gestion des Risques (PGR)
Conditions et statuts	– **Conditions de prescription et de délivrance** • Liste I • Médicament en réserve hospitalière (RH) • Prescription réservée aux spécialistes en oncologie ou en hématologie, ou aux médecins compétents en cancérologie ou en maladie du sang (PRS) • Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement (SPT)
Posologie dans l'indication évaluée	La dose recommandée de KEYTRUDA chez les adultes est soit de 200 mg toutes les 3 semaines (2 flacons), soit de 400 mg toutes les 6 semaines (4 flacons), administrée en perfusion intraveineuse pendant 30 minutes. Lorsque KEYTRUDA est utilisé en association à l'enfortumab vedotin, KEYTRUDA doit être administré après l'enfortumab vedotin lorsqu'il est administré le même jour. Pour plus de précision, se référer au RCP.
Classe pharmacothérapeutique	Il s'agit d'un anticorps monoclonal humanisé anti-PD-1.

Information au niveau international	Selon les informations transmises par le laboratoire à la date du dépôt du dossier : – Aux États-Unis, l'AMM a été octroyé le 15/12/2023 dans l'indication « KEYTRUDA, en association à l'enfortumab vedotin, est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer urothélial localement avancé ou métastatique ».
Rappel des évaluations précédentes	Autorisation initiale d'accès précoce post-AMM de KEYTRUDA 25 mg/mL, solution à diluer pour perfusion − 1 flacon en verre de 4 mL par le collège de la HAS, en application de l'article L.5121-12 du code de la santé publique, le 12/09/2024[1] dans l'indication suivante : « KEYTRUDA, en association à l'enfortumab vedotin, est indiqué dans le traitement de première ligne des patients adultes atteints d'un carcinome urothélial non résécable ou métastatique et éligibles à une chimiothérapie à base de sels de platine ». Et avis défavorable à l'autorisation d'accès précoce de KEYTRUDA (pembrolizumab) dans l'indication « KEYTRUDA, en association à l'enfortumab vedotin, est indiqué dans le traitement de première ligne des patients adultes atteints d'un carcinome urothélial non résécable ou métastatique et non-éligibles à une chimiothérapie à base de sels de platine ». La CT a déjà évalué KEYTRUDA 25 mg/ml (pembrolizumab)-boite de 1 flacon en verre de 4 ml dans l'indication de l'AMM « KEYTRUDA, en association à l'enfortumab vedotin, est indiqué dans le traitement de première ligne des patients adultes atteints d'un carcinome urothélial non résécable ou métastatique » et lui a octroyé un SMR important uniquement en association à l'enfortumab vedotin, dans le traitement de première ligne des patients adultes atteints d'un carcinome urothélial non résécable ou métastatique et éligibles à une chimiothérapie à base de sels de platine et un ASMR III par rapport aux chimiothérapies à base de sels de platine (Avis du 18/12/2024[2]). Avis défavorable au remboursement dans les autres situations couvertes par l'indication AMM. La CT a déjà autorisé l'inscription de ce complément de gamme KEYTRUDA 25 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en boite de 2 flacons en verre de 4 ml sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics le 9 avril 2025[3].
Evaluation par la Commission	– Calendrier d'évaluation : • Date d'examen et d'adoption : 19 novembre 2025. – Contributions de parties prenantes : Non – Expertise externe : Non

2. Environnement médical

Depuis le précédent avis rendu, l'environnement médical est inchangé.

3. Synthèse des données

Il n'existe pas de nouvelles données cliniques depuis le dernier avis de la CT.

[1] Décision n°2024.0238/DC/SEM du 12 septembre 2024 du collège de la Haute Autorité de santé portant autorisation d'accès précoce de la spécialité KEYTRUDA (pembrolizumab)

[2] CT-21037_KEYTRUDA_PIC_INS_AvisDef_CT21037.pdf

[3] CT-21288_KEYTRUDA_PIS_INS_AvisDef_CT21288.pdf

4. Conclusions de la Commission de la Transparence

Considérant l'ensemble de ces informations et après débat et vote, la Commission estime :

4.1 Maladie grave, rare ou invalidante

KEYTRUDA (pembrolizumab) en association au enfortumab vedotin est destinée à traiter une maladie grave et invalidante dès lors que le cancer urothélial est une maladie grave, engageant le pronostic vital, et invalidante dont les complications détériorent de manière importante la qualité de vie des patients. Ce retentissement sur la qualité de vie est corroboré par les associations de patients.

La combinaison est destinée à traiter une maladie rare car le nombre de patients en première ligne du carcinome urothélial au stade localement avancé ou métastatique est estimé à environ 6 221 patients par an au maximum.

4.2 Absence de traitement approprié

Dans l'indication retenue par la CT pour l'accès précoce, à savoir en association à l'enfortumab vedotin, dans le traitement de première ligne des patients adultes atteints d'un carcinome urothélial non résécable ou métastatique et éligibles à une chimiothérapie à base de sels de platine, il n'existe pas de traitement approprié, malgré l'existence de protocoles de chimiothérapie à base de sels de platine, actuellement recommandés au même niveau de la stratégie thérapeutique.

En effet, les protocoles de chimiothérapies à base de sels de platine ne sont pas considérés comme un traitement approprié dans la mesure où :

- La prise en charge repose sur la combinaison gemcitabine – cisplatine suivi par un traitement d'entretien par BAVENCIO (avelumab) chez les patients dont la maladie n'a pas progressé après la chimiothérapie à base de platine. Ces traitements sont accessibles et pris en charge par la solidarité nationale ;
- Les protocoles de chimiothérapies incluant le protocole gemcitabine-carboplatine en cas de contre-indication au cisplatine et MVACdd (méthotrexate + vinblastine + doxorubicine + cisplatine dose dense) sont utilisées hors AMM dans l'indication ;
- L'absence de perte de chance pour les patients qui recevraient ces protocoles de chimiothérapies ne peut être garantie du fait que ces spécialités ne disposent pas de données d'efficacité et de tolérance satisfaisantes au regard de l'apport prévisible de KEYTRUDA (pembrolizumab) en association au enfortumab vedotin.

Par ailleurs, deux spécialités disposent d'une AMM dans un périmètre restreint mais ne sont pas considérées comme des traitements appropriés car elles ne sont pas prises en charge par la solidarité nationale :

- OPDIVO (nivolumab) en monothérapie ;
- KEYTRUDA (pembrolizumab) en monothérapie.

4.3 Impossibilité de différer la mise en œuvre du traitement

La mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée puisqu'il s'agit d'une maladie grave, rare, et invalidante pour laquelle il n'existe pas de traitement approprié.

4.4 Caractère présumé innovant notamment au regard d'un éventuel comparateur cliniquement pertinent

KEYTRUDA 25 mg/ml (pembrolizumab), solution à diluer pour perfusion dans l'indication considérée, est présumé innovant dans l'indication considérée, car :

- il s'agit d'une nouvelle modalité de prise en charge susceptible d'apporter un changement substantiel aux patients dans la prise en charge du fait du bénéfice apporté en matière d'efficacité avec des différences estimées sur les médianes de 6,2 mois sur le critère de la survie sans progression et de 15,4 mois sur la survie globale ;
- on ne dispose pas de donnée sur l'apport de cette association chez les patients non éligibles aux sels de platine ;
- le médicament dispose d'un plan de développement adapté et présente des résultats cliniques, pour les patients atteints de cancer urothélial localement avancé ou métastatique naïfs de traitement étayant la présomption d'un bénéfice pour le patient dans le contexte de la stratégie thérapeutique existante ;
- il participe à couvrir davantage un besoin médical partiellement couvert.

4.5 Recommandations

La Commission donne un avis favorable à la modification de l'autorisation d'accès précoce de KEYTRUDA (pembrolizumab) dans l'indication « KEYTRUDA, en association à l'enfortumab vedotin, est indiqué dans le traitement de première ligne des patients adultes atteints d'un carcinome urothélial non résécable ou métastatique et éligibles à une chimiothérapie à base de sels de platine » pour y inclure les présentations :

KEYTRUDA 25 mg/ml, solution à diluer pour perfusion

- **1 flacon en verre de 4 ml (CIP : 34009 550 243 1 6) (UCD : 34008 9419723 2)**
- ***2 flacons en verre de 4 ml (CIP : 34009 551 048 6 5) (UCD : 34008 9419723 2)***

Pour rappel, il s'agit d'un avis rendu par la Commission de la Transparence, la décision d'autoriser ou non l'accès précoce revient au collège de la HAS.

HAS HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ
Développer la qualité dans le champ sanitaire, social et médico-social

© Haute Autorité de santé – novembre 2025